Buổi 3 (THIẾT KẾ): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 3 · Thứ Bảy 14/11/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word, hoặc in bản PDF. Không cần máy tính bỏ túi.

Phần	Nhiệm vụ	Khi nào
A	Gọi tên thiết kế của 6 tóm tắt ngắn	Cuối phần 3.1
B	Chọn thiết kế cho 5 câu hỏi lập kế hoạch, rồi cho câu hỏi của bạn	Cuối phần 3.2
C	Xây dựng đề cương 3: viết nháp mục 2.1 đến 2.3 của đề cương	Trên lớp, cuối buổi. Phần còn lại: ở nhà

Mỗi phần còn có **thực hành thêm** về các chủ đề khác, để tự học sau buổi.

Câu hỏi xuyên suốt: ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, chiến lược hạn chế dịch, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm tử vong 28 ngày không?

Chữ viết tắt: ICU = khoa hồi sức tích cực, RCT = thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng.

Phần A: Gọi tên thiết kế

Nhiệm vụ. Tự đọc từng tóm tắt. Ghi thiết kế (chọn trong danh sách bên dưới) và những từ trong tóm tắt cho thấy thiết kế đó. Chuẩn bị chia sẻ câu trả lời khi giảng viên mời.

Ba câu hỏi để gọi tên thiết kế

1. **Nhà nghiên cứu có chỉ định phơi nhiễm hoặc điều trị không?** Nếu có, **có ngẫu nhiên không?** Có: RCT. Không: nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên.
2. Nếu không chỉ định: **có nhóm so sánh không?** Không: nghiên cứu mô tả (báo cáo ca bệnh hoặc loạt ca bệnh).
3. Nếu có: **điều gì có trước?** Phơi nhiễm trước, rồi kết cục: thuần tập. Kết cục trước, rồi nhìn ngược lại: bệnh–chứng. Cả hai cùng một thời điểm: cắt ngang.

> **Chọn trong:** báo cáo ca bệnh hoặc loạt ca bệnh · cắt ngang · bệnh–chứng · thuần tập (tiến cứu hoặc hồi cứu) · nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên · RCT · tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Tóm tắt 1. Hai trăm người lớn bị sốc nhiễm khuẩn được máy tính trung tâm phân bổ ngẫu nhiên vào chiến lược hạn chế dịch hoặc chăm sóc thường quy. Tử vong trước ngày 28 được ghi nhận cho mọi người bệnh.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Tóm tắt 2. Vào một ngày trong tháng Ba, hai bác sĩ xem xét toàn bộ 64 người bệnh sepsis tại bốn ICU. Với mỗi người bệnh, họ ghi cân bằng dịch của ngày hôm đó và người bệnh có tổn thương thận cấp trong ngày hôm đó hay không.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Tóm tắt 3. Bốn mươi người bệnh sepsis tại ICU cần lọc máu mới được so sánh với 80 người bệnh sepsis tại cùng các đơn vị đó nhưng không cần lọc máu. Sau đó các nhà nghiên cứu xem lại hồ sơ bệnh án để tìm cân bằng dịch ngày 3 của từng người bệnh.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Tóm tắt 4. Dùng hồ sơ điện tử từ 2019 đến 2022, các nhà nghiên cứu xác định 900 người bệnh sốc nhiễm khuẩn và chia họ theo cân bằng dịch ngày 3 là dương hay âm. Sau đó họ so sánh số người bệnh tử vong trước ngày 28 ở mỗi nhóm.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Tóm tắt 5. ICU của bạn áp dụng quy trình hạn chế dịch cho mọi người bệnh sốc nhiễm khuẩn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tử vong trong sáu tháng trước được so sánh với tử vong trong sáu tháng sau.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Tóm tắt 6. Chúng tôi tìm kiếm trên ba cơ sở dữ liệu các thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh chiến lược hạn chế dịch với chiến lược truyền dịch tự do ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, đánh giá nguy cơ sai lệch của từng thử nghiệm, và gộp tử vong 28 ngày từ chín thử nghiệm.

Thiết kế: _____ Từ cho thấy thiết kế: _____

Thực hành thêm (tự học): các chủ đề khác

Cùng nhiệm vụ, với chín tóm tắt từ các khoa khác. Đáp án nằm trong phiếu đáp án, chia sẻ sau buổi học.

E1. Hai trăm bốn mươi người lớn thở máy được máy tính trung tâm phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm chăm sóc răng miệng bằng chlorhexidine hai lần mỗi ngày hoặc nhóm chăm sóc răng miệng chuẩn. Viêm phổi liên quan đến thở máy được ghi nhận trong 28 ngày bởi một người đánh giá không biết người bệnh thuộc nhóm nào.

E2. Vào một ngày trong tháng Ba, hai điều dưỡng đã được tập huấn khám toàn bộ 412 người bệnh nội trú của một bệnh viện để tìm tổn thương do tì đè và ghi loại đệm mỗi người bệnh đang nằm. Tổn thương do tì đè có ở 9% người bệnh nằm đệm thường và 4% người bệnh nằm đệm chống loét.

E3. Bốn mươi người bệnh ICU bị nhiễm nấm Candida máu được so sánh với 80 người bệnh ICU tại cùng các đơn vị không bị, ghép cặp theo tuổi và tháng nhập viện. Sau đó các nhà nghiên cứu tìm trong hồ sơ của cả hai nhóm việc nuôi dưỡng tĩnh mạch trong 14 ngày trước ngày cấy máu.

E4. Toàn bộ 600 người lớn nhập viện vì đột quỵ thiếu máu não cấp được dùng thuốc tiêu sợi huyết được phân loại ngay khi đến viện theo thời gian từ cửa đến kim (dưới 60 phút, hoặc từ 60 phút trở lên). Sau đó mỗi người bệnh được theo dõi để ghi nhận khả năng tự lập chức năng ở ngày 90.

E5. Dùng hồ sơ điện tử từ 2019 đến 2022, các nhà nghiên cứu xác định 1,150 người bệnh ICU và chia họ thành những người có và không được truyền benzodiazepine liên tục từ 3 ngày trở lên. Sau đó họ so sánh số người bệnh ở mỗi nhóm được ghi nhận mê sảng về sau trong thời gian nằm ICU.

E6. Chúng tôi mô tả năm người bệnh bị tăng natri máu nặng trong vòng một tuần sau khi khoa áp dụng quy trình truyền dịch mới, kèm kết quả xét nghiệm và diễn biến lâm sàng.

E7. Tỷ lệ sepsis liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm được so sánh giữa sáu tháng trước và sáu tháng sau một chương trình đào tạo về gói đặt catheter trên toàn khoa, do nhóm nghiên cứu triển khai cho mọi giường bệnh cùng một ngày.

E8. Mười hai khoa phòng của bệnh viện được phân bổ ngẫu nhiên, theo từng khoa, vào chương trình phản hồi vệ sinh tay mới hoặc thực hành thường quy. Nhiễm khuẩn bệnh viện được đếm ở mọi người bệnh trong các khoa đó trong sáu tháng.

E9. Hôm nay toàn bộ 300 người bệnh nội trú được kiểm tra có đặt ống thông tiểu không và có nhiễm khuẩn tiết niệu không.

Phần B: Chọn thiết kế

Nhiệm vụ. Với mỗi câu hỏi lập kế hoạch, ghi thiết kế tốt nhất mà bạn thực sự làm được, một lý do chọn thiết kế đó, và điểm yếu chính của nó. Chuẩn bị chia sẻ câu trả lời khi giảng viên mời.

> **Chọn trong:** bất kỳ thiết kế nào ở Phần A, hoặc một thiết kế của phần 3.2: RCT không kém hơn · RCT theo cụm · chuỗi thời gian ngắt quãng · phỏng vấn sâu hoặc thảo luận nhóm (định tính) · nghiên cứu thí điểm hoặc khả thi

#	Câu hỏi lập kế hoạch (đều về câu hỏi dịch truyền xuyên suốt)	Thiết kế	Lý do	Điểm yếu chính
1	Chiến lược hạn chế dịch rẻ hơn và dùng ít dịch hơn. Chỉ cần chứng minh tử vong 28 ngày không tệ hơn so với chăm sóc thường quy.			
2	Một quy trình ghi chép cân bằng dịch do điều dưỡng thực hiện sẽ được áp dụng cho cả ICU. Điều dưỡng trong một ICU không thể chỉ áp dụng cho một nửa số người bệnh.			
3	Gói xử trí sepsis của bệnh viện, trong đó có giới hạn dịch duy trì, bắt đầu từ năm 2023. Đã có số liệu tử vong do sepsis hằng tháng trong 3 năm trước và 2 năm sau. Tử vong có giảm không?			
4	Vì sao điều dưỡng trực đêm thấy khó ghi lượng nước tiểu?			
5	Trước một thử nghiệm lớn: hai ICU của mình có tuyển đủ người bệnh và thực hiện hạn chế dịch đúng kế hoạch được không?			

Câu hỏi của bạn. Ghi câu hỏi nghiên cứu của bạn, thiết kế bạn sẽ dùng, và điều bạn được phép nói ở cuối nghiên cứu: "gây ra" hay chỉ "có liên quan với".

Câu hỏi của tôi: _____

Thiết kế của tôi: _____ Tôi được nói: "gây ra" / "có liên quan với" (khoanh một)

Thực hành thêm (tự học): các chủ đề khác

#	Câu hỏi	Thiết kế	Lý do
E1	Hôm nay có bao nhiêu người bệnh nội trú bị tổn thương do tì đè, và tổn thương có phổ biến hơn ở người nằm đệm thường không?		
E2	Tắm bằng chlorhexidine hằng ngày có làm giảm nhiễm khuẩn dòng máu không? Biện pháp sẽ được áp dụng theo từng khoa.		
E3	Các yếu tố nguy cơ của một biến cố hiếm là gì: hội chứng Stevens-Johnson ở người bệnh nằm viện?		
E4	Vì sao điều dưỡng không báo cáo các sự cố suýt xảy ra về thuốc?		

Phần C: Xây dựng đề cương 3 (thiết kế, bối cảnh và đối tượng)

Nhiệm vụ. Viết nháp mục 2.1 đến 2.3 của đề cương cho câu hỏi của bạn. Trước tiên xem giảng viên điền các mục này cho ví dụ xuyên suốt, rồi tự viết trên lớp (khoảng 20 phút). Nếu chưa xong, làm tiếp ở nhà. Sau đó chép câu trả lời vào Phần 2 của mẫu đề cương (`Research_Proposal_Template_VN.docx`). Mục 2.4 đến 2.6 (phơi nhiễm, kết cục, sai lệch) làm ở Buổi 4.

Câu hỏi nghiên cứu của tôi (từ Phần 1 đề cương):

_____

Mục	Cần viết gì	Câu trả lời của tôi
2.1 Thiết kế nghiên cứu và lý giải	Gọi tên thiết kế. Trong 3 đến 5 câu, giải thích vì sao thiết kế phù hợp với câu hỏi của bạn, và vì sao thiết kế lý tưởng khả thi hay không khả thi.	
2.2 Bối cảnh	Ở đâu (loại đơn vị, bao nhiêu cơ sở), khi nào (thời gian nghiên cứu), và nguồn người bệnh hoặc hồ sơ. Bạn không cần nêu tên bệnh viện.	
2.3 Đối tượng nghiên cứu	**Tiêu chuẩn chọn** (3 đến 5): ai đủ điều kiện. **Tiêu chuẩn loại trừ** (3 đến 5): ai bị loại, và vì sao. Tiêu chuẩn loại trừ không chỉ là tiêu chuẩn chọn viết ở dạng phủ định.	

Phác họa nghiên cứu của bạn trên trục thời gian. Ghi khi nào đo phơi nhiễm và khi nào đo kết cục:

Bắt đầu: đo phơi nhiễm	Theo dõi	Kết thúc: đo kết cục

Tự kiểm tra trước khi hoàn thành

- ☐ Thiết kế phù hợp với loại câu hỏi.
- ☐ Thiết kế khả thi trong bối cảnh của tôi (người bệnh, thời gian, dữ liệu).
- ☐ Tiêu chuẩn chọn mô tả P (đối tượng) trong PICO của tôi và có thể kiểm tra từ hồ sơ ngay ngày 1.
- ☐ Mỗi tiêu chuẩn loại trừ đều có lý do (an toàn, không đo được kết cục, v.v.).
- ☐ Tôi biết mình sẽ được phép khẳng định điều gì: "gây ra" hay "có liên quan với".